

返院适应期专项任务包

生成时间：2026-05-29 19:31:03

返院适应期专项任务包

****长者姓名****：陈萍忠

****当前阶段****：返院初期（BPSD症状缓解期，NPI评分16分）

****疾病分期****：阿尔茨海默病中重度期（Stage 4）

****风险等级****：BPSD复发风险（高）、跌倒风险（高）、照护强度需求（加强）

一、用药指导

****服务内容****：

1. 确保每日按时服用医嘱药物，包括降压药、调脂药（如瑞舒伐他汀）、认知改善药（多奈哌齐、美金刚）及精神科药物（如奥氮平、劳拉西泮）。
2. 每日晨起及晚间服药时，由照护员核对药品名称、剂量，并观察吞咽是否顺利。
3. 监测药物不良反应，重点关注皮肤瘀斑、牙龈出血（提示血小板减少）、发热或感染征象（提示白细胞减少）。

****频次****：

- 药物发放与核对：每日2次（早、晚）
- 不良反应观察：每次服药时及日常照护中持续留意

****注意事项****：

- 避免自行调整药物剂量或停药。
- 计划于返院第7日内完成全面用药审查及血常规复查（参考14天照护目标）。

二、跌倒防护

****服务内容****：

1. 实施24小时防跌倒措施，重点保障夜间如厕安全：老人如厕时必须全程陪护，协助起身、行走及返回床铺。
2. 洗澡时全程协助，使用防滑垫、扶手及沐浴椅，水温控制在38 – 40℃。
3. 日间平地行走时提供部分辅助（如使用助行器或照护员搀扶），避免独自行走。
4. 保持地面干燥无障碍，夜间开启柔和地灯。

****频次****：

- 夜间如厕陪护：按需（每次如厕）
- 洗澡协助：每日1次（或按老人习惯）
- 日间行走辅助：每次离床活动时

****注意事项**：**

- 起床或久坐后起身时，需静坐30秒再站立，预防体位性低血压。
- 定期检查助行器及防滑设备安全性。

三、认知干预（结合跳舞喜好）

****服务内容**：**

1. 组织结构化跳舞活动，选择节奏舒缓、动作简单的音乐（如民族舞、广场舞慢速版），每次15 – 20分钟。
2. 活动中鼓励老人跟随节拍摆动、踏步，照护员同步示范并给予积极反馈。
3. 若老人出现抗拒，不强行参与，可改为聆听音乐或观看舞蹈视频。

****频次**：**

- 跳舞活动：每日1次，安排在下午15:00 – 16:00（契合“提升下午日间参与度”目标）

****注意事项**：**

- 活动区域确保宽敞、无障碍，地面防滑。
- 密切观察体力状况，若出现气促、出汗过多立即停止。
- 可结合其他认知刺激（如简单手工、怀旧音乐）交替进行，避免单调。

四、BPSD症状监测

****服务内容**：**

1. 每日观察并记录老人情绪、行为变化，重点关注：拒绝配合指令、言语攻击、激越、徘徊、幻觉等。
2. 使用简化版NPI量表，由护士每周进行2次标准化评估（周一、周四），记录评分及具体表现。
3. 发现BPSD症状加重迹象（如连续2天拒绝进食或攻击行为），立即上报医疗团队。

****频次**：**

- 日常行为观察：每日持续

- 护士NPI评估：每周2次

****注意事项**：**

- 评估时选择老人情绪平稳时段，避免干扰。
- 记录需具体（如“15:00拒绝参与跳舞，挥手示意离开”），而非笼统描述。

五、家属支持

****服务内容**：**

1